

Vue d'ensemble du parcours

SEPTEMBRE 2025 – JUIN 2026

ÉPISODES DOCUMENTÉS 5 Consultations, biologie, séjour	SOURCES PRIMAIRES 5 documents SAN-01 à SAN-03, SAN-05, SAN-06	POINTS À CONCILIER 3 Allergie, dose, suivi biologique
--	--	--

Problèmes actifs recensés

- Hypertension artérielle traitée depuis 2017.
- Fibrillation atriale permanente sous anticoagulation orale depuis 2021.
- Dégradation de la fonction rénale objectivée en juin 2026.
- Épisode de déshydratation avec malaise ayant conduit à une hospitalisation du 23 au 25 juin 2026.

Portée de cette synthèse

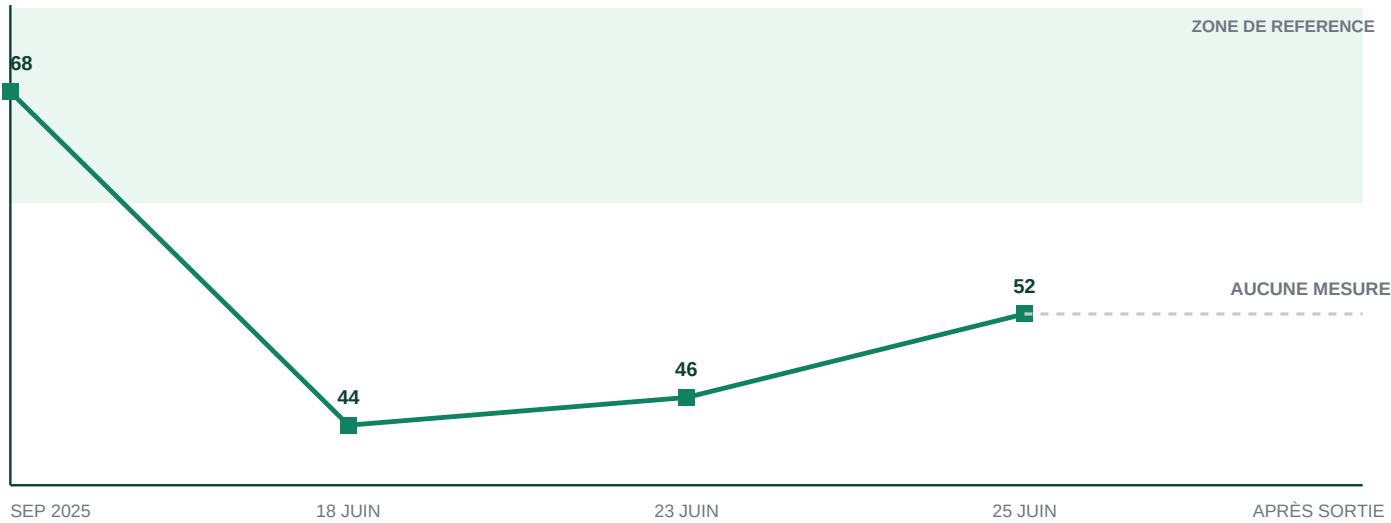
Ce document réunit des informations issues de plusieurs sources primaires et en conserve les divergences. Il ne remplace aucune source et n'arbitre aucune contradiction : chaque élément reste rattaché au document qui le porte.

DOCUMENT SOURCE	DATE	APPORT PRINCIPAL
Note de consultation	12 janvier 2026	Antécédents, allergie, traitements actifs
Ordonnance	15 janvier 2026	Doses prescrites en ville
Résultats de laboratoire	18 juin 2026	Dégradation de la fonction rénale
Courrier de cardiologie	20 juin 2026	Dose divergente et demandes de vérification
Compte rendu d'hospitalisation	25 juin 2026	Séjour, biologie, traitement de sortie

Toutes les valeurs reprises ici sont recopiées sans conversion ni arrondi depuis les documents sources cités en regard.

Trajectoire de la fonction rénale

PAGE 2 / 5



Débit de filtration glomérulaire estimé, en mL/min/1,73 m². La zone claire matérialise l'intervalle de référence du laboratoire (> 60).

DATE	VALEUR	SOURCE DOCUMENTAIRE
Septembre 2025	68 mL/min/1,73 m²	Note de consultation du 12 janvier 2026, page 2
18 juin 2026	44 mL/min/1,73 m²	Compte rendu de laboratoire du 18 juin, page 1
23 juin 2026	46 mL/min/1,73 m²	Compte rendu de sortie du 25 juin, page 3
25 juin 2026	52 mL/min/1,73 m²	Compte rendu de sortie du 25 juin, page 3
Après la sortie	Aucune mesure au dossier	Absence constatée au 10 juillet 2026

Lecture de la courbe

La valeur de septembre 2025 est la seule antériorité disponible avant juin 2026 : l'intervalle entre les deux premiers points ne comporte aucune mesure intermédiaire. La remontée observée entre le 18 et le 25 juin suit la prise en charge hospitalière. Le segment en pointillé signale l'absence de mesure après la sortie, et non un retour à la valeur initiale.

Matrice problèmes et traitements

PAGE 3 / 5

TRAITEMENT	ORDONNANCE 15/01	LETTRE CARDIO 20/06	SORTIE 25/06
Rivaroxaban	20 mg	15 mg	20 mg
Ramipril	5 mg	5 mg	5 mg
Bisoprolol	2,5 mg	2,5 mg	2,5 mg
Atorvastatine	20 mg	Non citée	20 mg

DIVERGENCE DE DOSE NON TRANCHÉE

Trois documents décrivent la même période avec deux doses différentes de rivaroxaban. Aucune source ne documente l'auteur, la date ni le motif d'un changement. La dose réellement prise ne peut être établie à partir du dossier.

PROBLÈME ACTIF	TRAITEMENT RATTACHÉ	ÉLÉMENT DE SURVEILLANCE DOCUMENTÉ
Fibrillation atriale	Rivaroxaban, bisoprolol	Fonction rénale, à rapprocher de la dose
Hypertension artérielle	Ramipril	Tension artérielle, kaliémie
Dyslipidémie	Atorvastatine	Bilan lipidique, non présent au dossier
Atteinte rénale	Aucun traitement spécifique	Créatinine et potassium

Ce que la matrice ne permet pas de conclure

La matrice juxtapose des sources sans les hiérarchiser. Elle ne permet pas de déterminer quelle dose a été effectivement prise, ni d'attribuer la divergence à une erreur de transcription, à une modification non tracée ou à une information transmise oralement.

Séjour hospitalier et suivi attendu

PAGE 4 / 5

Chronologie établie à partir des documents figurant au dossier. Chaque étape renvoie au document qui la porte ; aucune étape n'est reconstituée par déduction.

18 juin

Bilan biologique de ville
Créatinine 118 µmol/L, DFG 44 mL/min/1,73 m², potassium 5,3 mmol/L. Le compte rendu porte un commentaire automatique de stabilité.

20 juin

Avis de cardiologie
Le spécialiste mentionne le DFG à 44 et une liste de traitements comportant rivaroxaban 15 mg par jour. Il demande une vérification de la fonction rénale et de la dose réellement prise.

23 juin

Admission hospitalière
Prise en charge pour déshydratation et malaise. DFG à 46 mL/min/1,73 m² à l'entrée.

25 juin

Sortie
DFG à 52 mL/min/1,73 m². Traitement de sortie mentionnant rivaroxaban 20 mg le soir. Contrôle de la créatinine et du potassium demandé sous sept jours.

2 juillet

Échéance du contrôle demandé
Aucun résultat de contrôle n'est présent au dossier à la date d'établissement de la présente synthèse.

JALON ATTENDU	DATE THÉORIQUE	PRÉSENCE AU DOSSIER
Contrôle biologique post-sortie	2 juillet 2026	Absent
Consultation de suivi	5 juillet 2026	Absente
Réponse au courrier de cardiologie	Non datée	Absente

Qualité des données et points à vérifier

PAGE 5 / 5

ÉLÉMENT	CE QUE DIT LE DOSSIER	STATUT
Allergie médicamenteuse	Amoxicilline avec éruption en 2019 selon la note du 12 janvier ; mention « aucune connue » au compte rendu de sortie	Contradiction ouverte
Dose de rivaroxaban	20 mg, puis 15 mg, puis 20 mg selon les documents	Conciliation requise
Ligne allergie à la sortie	Non renseignée dans la présente synthèse	Ne pas compléter sans source
Contrôle biologique post-sortie	Demandé sous 7 jours, aucun résultat joint	Donnée absente
Commentaire de laboratoire	Indique une stabilité malgré une baisse de 68 à 44	À signaler au prescripteur

LIMITE DE LA SYNTHÈSE

Ce document sert à préparer une relecture par un professionnel. Il ne propose ni diagnostic, ni adaptation de dose, ni conduite thérapeutique, et laisse visibles les informations manquantes plutôt que de les combler.

Utilisation recommandée de ce document

Cette synthèse sert de point de départ à une relecture du dossier par un professionnel : elle rassemble les sources, signale les divergences et rend visibles les données manquantes. Toute décision reste fondée sur les documents primaires et sur l'examen clinique.

VÉRIFICATION SUGGÉRÉE	DOCUMENT À CONSULTER EN PRIORITÉ
Statut réel de l'allergie	Note de consultation du 12 janvier 2026, page 2
Dose effectivement délivrée	Relevé de délivrance en officine, non présent au dossier
Évolution rénale après la sortie	Résultat du contrôle demandé au 2 juillet 2026
Motif d'une éventuelle modification de dose	Correspondance entre professionnels